

安定的药物相互作用

河北医学院第二医院 樊德厚

安定在临床各科室应用甚为广泛,但是对其相互作用只见到一些散在报道,本文试图按以下三方面综合介绍其相互作用情况。

有益的相互作用

1. 24例小儿癫痫大发作患者,用安定0.5~1.25mg/次,一天3次,并用谷氨酸0.5~1.0g/次,一天3次,1~2个月一疗程,控制发作较其它抗癫痫药显著。

2. 治疗神经官能症伴失眠患者常将安定与苯巴比妥并用,能增强中枢抑制效应。老年人易造成精神错乱甚至昏厥,且易产生耐受性,故应减量慎用。

3. 异烟肼可削弱安定的代谢运转,可抑制安定排泄,会明显增加安定的清除率。另外,安定可延缓或减少利福平在胃肠道中的吸收,降低其抗结核菌效果,如须合用宜分别相隔8~12小时。

4. 安定与麻醉剂合用可发生暂时性低血压,呼吸抑制等反应,可增强应定的作用,如须合用应减少麻醉剂用量。安定对氯胺酮麻醉恢复期的幻觉及躁动有防治作用,可作为麻醉前用药或临时用于对症治疗。

5. 安定可加强噻嗪类及其它利尿剂的抗高血压效用。

6. 氟哌啶醇与安定合用时中枢抑制作用加强,故应适当减少剂量。

7. 安定与甲氧咪胍并用可使安定的血浆廓清率明显降低,血药浓度升高,作用和不良反应(困倦、头昏、运动失调、动作不协调等)显著增加。相互作用机理是甲氧咪胍的酶抑作用导致安定在肝内代谢减慢,致使同用药物的血浓度升高,药理作用加强或延长。

8. 安定若与苓桂术甘汤合用,用量只需常规的1/3,嗜睡等副作用也因并用中药而消除。

有益甚至有害的相互作用

1. 安定与利眠宁合用可引起遗尿。

2. 安定与甲碘安并用可使用碘安从蛋白结合中游离出来,游离易吸收,血药浓度增高而引起中毒症状。使用过量时,可引起脉搏加快,不规则,肌肉颤动,甚至心绞痛、心衰等,对动脉硬化,冠心

病患者更应注意。

3. 安定与单胺氧化酶抑制剂并用时增强中枢神经抑制作用,一般不宜合用。

4. 安定与度冷丁合用可引起呼吸停止。

5. 安定与阿米替林合用可造成肝脏损伤。

6. 服安定患者不宜饮酒。在进行精神运动性或抑其它试验时两药对中枢制作用均增加。其相互作用较利眠宁与乙醇为强。

7. 双硫醒将使安定的作用增强。半衰期延长。其相互作用机理是双硫醒抑制许多肝微粒体酶,因此合并应用的各种药物的代谢都降低。应预想两药合将会加强镇静作用。另外,苯二氮草类能减低双硫醒——乙醇的相互作用。

8. 安定与利多卡因:动物试验证明,先静脉注射安定可增强利多卡因抗心律失常作用。

9. 安定有抗维生素K作用,对凝血过程有一定抑制作用,长期应用可引起出血倾向。

10. 安定为有机溶媒制成的水不溶性注射剂,与水性注射剂如564—2、ATP、红霉素、阿托品、维生素B₁、B₆、普鲁卡因、氯化钠、碳酸氢钠配伍常因溶解度改变而使安定检出。安定亦不宜加入输液中,亦不宜进一步稀释。

尚待证实的相互作用

1. 苯妥英钠与安定配伍是门诊癫痫病的常用药物,一般书籍都认为有一定的协同作用,但安定可抑制羟化酶,使苯妥英钠的代谢减慢,在体内蓄积,血浓度增加,易招致中气反应,因此在两药并用时苯妥英钠的用量应适当减少。

2. 一例锂盐与安定合用出现严重的低温(35°C以下),而单独服用其中一种药时无此现象发生。在监测相互作用时病人同服此二药(每天锂盐1g,安定30mg),17天后,体温从35.4°C降至32°C,持续2小时以上,同时出现昏迷,反射减低,瞳孔散大,收缩压40—60mmHg,脉搏40,无竖毛反应。作用机理不清,虽1例报道,但可供参考。

3. 安定与抗酸剂:一般认为安定与碱性药合用时减少肾小管的排泄,吸收延迟,血浓度增高,作用增强。也有认为两药并用临床意义尚难确定,可能影响不大。

另外,安定若与酸性药物合用时排泄增加,疗

效降低。也尚需临床更多资料加以证实。

4. 安定与三环类抗抑郁药：前述安定与阿密替林合用对肝脏有损害。另一报告则认为硝基安定，安定、舒宁和利眠宁对于去甲替林和阿米替林稳态血浆浓度的影响，以及安定和利眠宁对于去甲替林

的影响都未发现有任何相互作用。另一项研究证实由于合并应用安定而使阿密替林的血浓度升高。结论是没有理由认为任何其它三环类抗抑郁药与苯二氮草类合用有不良的相互作用。

(参考文献略)

氨 噻 羧 单 胺 菌 素

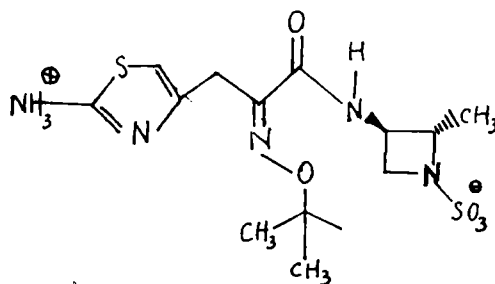
桂林南溪山医院 杨俊何

氨噻羧单胺菌素(又名噻吩单酰胺菌素, SQ 26776, Aztreonam, 简称AZ)是第一个用于临床的单环 β -内酰胺抗生素, 它具有第三代头孢菌素和第四代青霉素的性质, 对革兰氏阴性菌的青霉素结合蛋白有高度亲和力, 对 β -内酰胺酶和脱氢肽酶也有高度稳定性。AZ分子结构的主要特点是磺酸基在N-位上取代了双环 β -内酰胺抗生素的五元环或六元环(附图)磺酸基是主要的活性基团, 4位上的 α -甲基增加了对 β -内酰胺酶的稳定性, 酰基侧链的噻吩对严氧性革兰氏阴性菌有强大活力, 脲侧链上的羧基团增加了对假单胞菌的活性。

抗菌活性^[1-3] AZ对革兰氏阴性菌的活性相当于或强于第三代头孢菌素, 对临床分离的各种革兰氏阴性杆菌的MIC₉₀ ($\mu\text{g/ml}$), 与氨噻唑头孢菌素(CTX)、羧氧酰胺菌素(LMOX)和庆大霉素(GTM)比较, AZ活性最强的有奇异变形杆菌(<0.1)、吲哚阳性变形杆菌(<0.1)、粘质沙雷氏菌(0.9), 对大肠杆菌(0.2)和肺炎杆菌(0.2)的敏感性近似于CTX, 先于LMOX和GTM, 对沙门氏菌(0.3)和柠檬酸菌(0.7)各抗生素几乎相同, 对肠道细菌(15)和假单胞菌(15)强于CTX和LMOX, 但弱于GTM, 对淋球菌(0.2)优于GTM, 对流感嗜血杆菌(0.2)略差于GTX(0.1)和LMOX(≤ 0.1), 但优于GTM(3.0~3.1), 对不动杆菌(66)在的些品种里居中, 实验证明, AZ对许多药物(如唑林头孢菌素、甲酰苯唑头孢菌素、噻吩甲氧头霉素、羧噻吩青霉素、氨基青霉素、氧哌唑头孢菌素和氨基糖苷类抗生素)耐药的细菌(如绿脓杆菌粘质沙、雷氏菌、肺炎杆菌、流感嗜血杆菌和多种肠杆菌科)有很强的活性。

AZ的抗菌活性, 在pH6.0~8.0几乎不受培养基的种类和接种量的影响, 但对革兰氏阳性菌或厌氧几乎无活性。

药动学^[3,4] AZ在正常人的药动学近似于羧酰胺菌素和氧哌唑头孢菌素。一次静脉注射AZ 1g后的血峰浓度为93.4 $\mu\text{g/ml}$, 注射2g的血浓度超过绿脓杆菌和阴沟杆菌MIC₉₀的时间维持4~6小时, 静脉或肌内注射0.5~2g, 对大多数肠杆菌科细菌、嗜血杆菌和淋球菌的有效治疗浓度维持8~12小时。肌内和静脉注射后1小时的血浓度相似, 肌内注射后吸收完全、迅速(吸收半衰期0.4小时), 且分布也极快(α 相半衰期0.2小时), 稳态容积分布0.18L/kg, 血浆蛋白结合率为56%。



静脉注射AZ 1g后30分钟的唾液浓度为0.2 $\mu\text{g/ml}$ 。正常人静脉注射2g后1和4小时的血浆浓度各为0.6和1.0 $\mu\text{g/ml}$, 但在脑膜炎病人可达2.0和3.2 $\mu\text{g/ml}$, 脑脊液在给药后2~4小时达峰浓度。因此, 每6小时给药一次对革兰氏阴性菌脑膜炎有效。腹内感染患者, 静脉注射后的腹腔液药浓度与血清相当, 肾切除的病人, 静脉注射2g后在肾皮质、肾髓质和肾乳头的浓度依次为4.6~70、31~61和34~103 $\mu\text{g/ml}$ 。

静脉注射AZ 0.5g后的有效尿药浓度可维持12~24小时, 约2/3以原形从尿中排泄, 血清半衰期为1.7小时, 其血清清除率与尿肌酐清除率有线性关系, 无尿症病人的血清清除率降为正常人的1/4, 平均消除半衰期3倍于正常人。在胆道疾病和乙醇性肝硬化患者的平均清除半衰期分别为2.2和3.2小